



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 05 — Sepse e Choque Séptico (adulto; notas pediátricas)

Reconhecimento, pacote da 1ª hora, ressuscitação hemodinâmica, antimicrobiano empírico por foco e regulação — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-05	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Sepse é disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por resposta desregulada do hospedeiro à infecção (Sepsis-3, JAMA 2016). É emergência tempo-dependente: cada hora de atraso no antimicrobiano e na ressuscitação aumenta a mortalidade. Este protocolo define o que o PS Natal Diegues faz nas **primeiras 6 horas** — tudo o que está no pacote da 1ª hora é executável aqui, inclusive vasopressor em veia periférica, enquanto a regulação para UTI é acionada em paralelo.

Fontes de ancoragem: ILAS — Instituto Latino-Americano de Sepsis. *Implementação de protocolo gerenciado de sepsis: protocolo clínico — atendimento ao paciente adulto com sepsis/choque séptico* (rev. ago/2018; documento vigente no site do ILAS) [ILAS]; ILAS, *Nota técnica sobre as diretrizes SSC 2021; Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026* (Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Crit Care Med / Intensive Care Med, mar/2026; 129 recomendações, 46 novas) [SSC 2026]; SSC 2021 (Evans L, et al. Crit Care Med 2021;49:e1063) para itens mantidos; Singer M, et al. Sepsis-3, JAMA 2016;315:801; ILAS/CFM, *Sepsis: um problema de saúde pública*, 2016; SSC Pediatric 2020 (Weiss SL, et al. Pediatr Crit Care Med 2020) para as notas pediátricas.

Convenção de confiança: os esquemas antimicrobianos empíricos são propostas de prática consagrada que **devem ser validadas pela CCIH/SCIH municipal e pela farmácia (REMUME)** antes da aprovação — marcados [VERIFICAR]. Doses de vasoativos e de corticoide vêm do ILAS/SSC. Nada substitui o julgamento clínico.

1. Queixa — como o paciente chega

A sepsis não tem queixa própria: chega como a infecção de origem **mais** um sinal de que o organismo está falhando. Padrões típicos na porta: "febre e muita fraqueza", "ficou confuso/sonolento desde ontem" (sobretudo idoso), "não urina desde de manhã", "falta de ar e calafrios", "tosse com febre e prostração", "dor para urinar e tremores", "ferida na perna que piorou e febre", "vômitos, dor na barriga e febre". Familiares descrevem "não é ele", "está muito mole", "a pele ficou manchada".

Grupos em que a apresentação é silenciosa: idosos (hipotermia, delirium, quedas, sem febre), imunossuprimidos, diabéticos, usuários de corticoide/betabloqueador (sem taquicardia), pós-operatório recente, portadores de cateteres/sondas, neutropênicos, cirróticos, usuários de drogas injetáveis, puérperas, esplenectomizados.

2. Clínica — triagem, definições e disfunção orgânica

2.1 Triagem (abrir o protocolo) — sensibilidade alta

O ILAS orienta abrir o protocolo na **suspeita de infecção + ≥ 2 critérios de SRIS** ou na **suspeita de infecção + qualquer disfunção orgânica** [ILAS, seção 3]. O SSC 2026 recomenda NEWS/NEWS2, MEWS ou SIRS **em vez do qSOFA** como ferramenta única de triagem (forte, moderada); o qSOFA fica para prognóstico, não para triagem.

SRIS (≥ 2)	qSOFA (≥ 2 = alto risco de óbito; não usar para triagem)
T $>38,3$ °C ou <36 °C • FC >90 • FR >20 ou PaCO ₂ <32 • leucócitos >12.000 ou <4.000 ou $>10\%$ bastões	FR ≥ 22 • alteração do nível de consciência • PAS ≤ 100 mmHg

2.2 Definições operacionais [ILAS, Tabela 1; Sepsis-3]

Categoria	Definição	Conduta-chave
Infecção sem disfunção	Foco suspeito/confirmado, com ou sem SRIS, sem disfunção orgânica	Avaliação rápida; antimicrobiano em até 3 h se a suspeita persistir (SSC 2026: "sepse possível sem choque"); observar; baixo risco (IVAS, jovem sem comorbidade) pode seguir fluxo simplificado
Sepse	Infecção suspeita/confirmada + ≥ 1 disfunção orgânica sem outra explicação	Pacote da 1ª hora ; antimicrobiano imediato (≤ 1 h); leito monitorado
Choque séptico	Sepse com hipotensão que persiste após volume inicial, exigindo vasopressor para PAM ≥ 65 (ILAS/SSC); Sepsis-3 acrescenta lactato >2 mmol/L	Vasopressor em ≤ 1 h (periférico se preciso); UTI em ≤ 6 h → regular imediatamente

2.3 Disfunções orgânicas que definem sepse [ILAS, seção 2]

- Hipotensão: PAS <90 , PAM <65 ou queda >40 mmHg da habitual
- Oligúria $\leq 0,5$ mL/kg/h ou creatinina >2 mg/dL
- PaO₂/FiO₂ <300 ou necessidade de O₂ para SpO₂ $>90\%$
- Plaquetas <100.000 ou queda de 50% em 3 dias
- Lactato acima do valor de referência
- Rebaixamento de consciência, agitação, delirium
- Bilirrubina $>2\times$ o valor de referência

Uma disfunção sem outra causa + foco presumível = sepse → iniciar o pacote agora.

2.4 Foco infeccioso — pistas por sistema

Foco	Pistas	Diferenciais não infecciosos que mimetizam sepse
Pulmonar (mais comum)	Tosse, dispneia, dor pleurítica, estertores, consolidação, SpO ₂ baixa	TEP, IC descompensada, aspiração química, SDRA
Urinário	Disúria, dor lombar, Giordano +, sonda vesical, idoso com delirium	Cólica renal sem infecção
Abdominal	Dor, defesa, distensão, icterícia, cirurgia recente, diverticulite, colangite	Pancreatite, isquemia mesentérica, perfuração
Pele/partes moles	Celulite, abscesso, ferida, úlcera de pé diabético, dor desproporcional/crepitação (necrotizante)	TVP, gota, dermatite de estase
SNC	Cefaleia, rigidez de nuca, petéquias, convulsão	AVC, hemorragia, intoxicação
Cateter / dispositivo / IRAS	Internação <90 dias, hemodiálise, CVC, sonda, antibiótico recente, ILPI	—
Arbovirose / malária / leptospirose	Epidemiologia; dengue tem fluxo próprio (Protocolo 11) — não tratar choque da dengue com antibiótico	Ver Protocolo 11

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado que muda a conduta
Sinais vitais + PAM	PAM <65 (ou 60-65 em ≥65 anos — SSC 2026); FR ≥22; FC >90; T <36 é pior que febre; SpO ₂ <90%
Perfusão	Tempo de enchimento capilar >3 s (SSC 2026: usar como guia adjunto), livedo/pele mosqueada, extremidades frias e úmidas, cianose — choque instável mesmo com PA "normal"
Consciência	Glasgow, confusão nova, sonolência — disfunção orgânica e sinal de choque instável
Diurese	Perguntar/medir; oligúria = hipoperfusão; sonda vesical se choque
Busca do foco	Pulmão (estertores, macicez), abdome (peritonismo, Murphy, Giordano), pele (celulite, crepitação, bolhas, escara), meninges, orofaringe/dentes, sítios de cateter, genitália/puerpério, próstata (toque)
Fontes de controle cirúrgico	Abscesso, empiema, colangite obstrutiva, obstrução urinária infectada, fascíte, isquemia intestinal, corpo estranho/cateter infectado → controle do foco em ≤6 h (SSC 2026) — geralmente implica transferência

4. Propedêutica armada — pacote de exames [ILAS, pacote 1 h; SSC 2026]

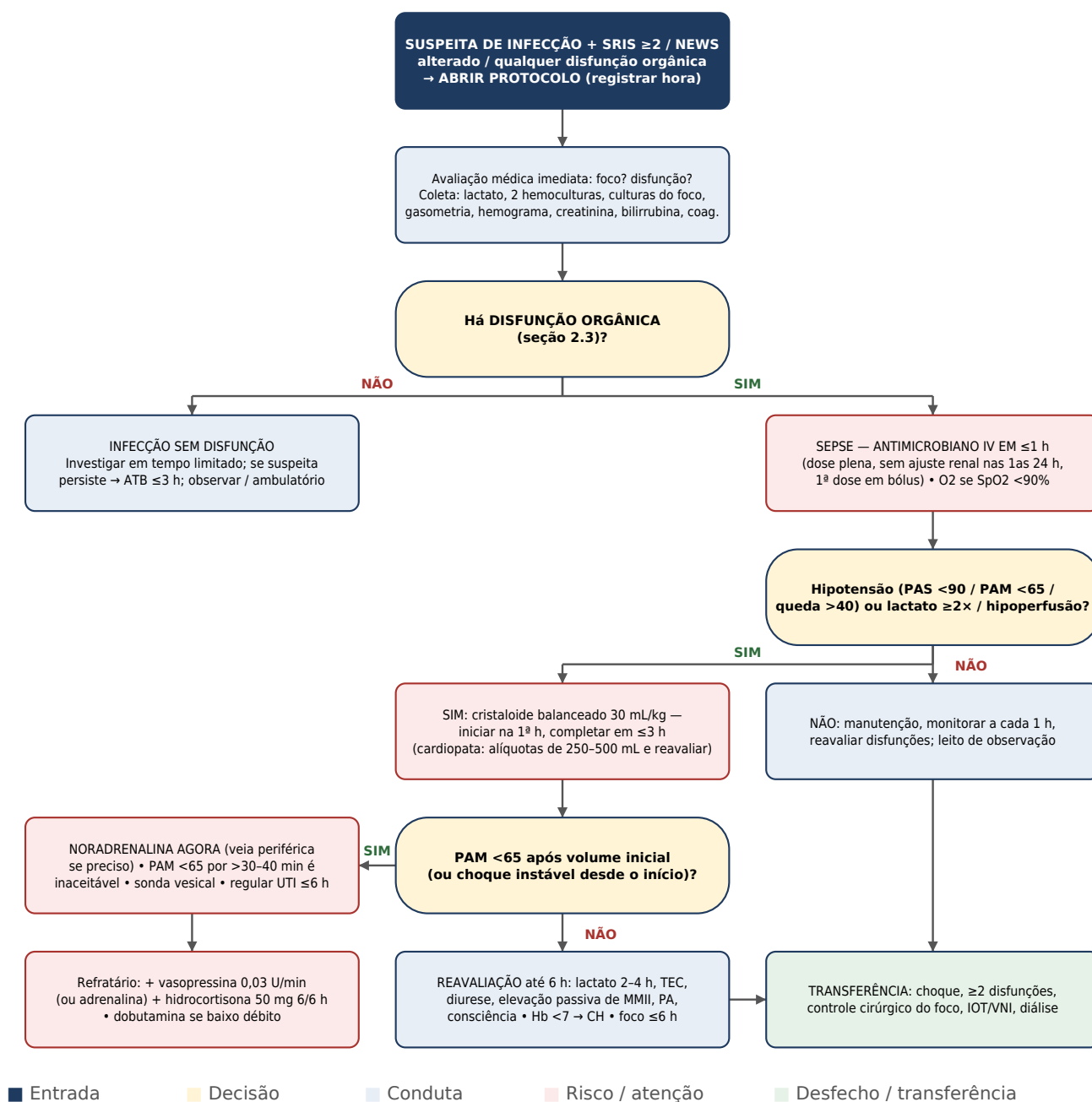
Exame	O que esperar / para que serve	Prazo
Lactato arterial (ou venoso se impossível)	>2 mmol/L (18 mg/dL) = hipoperfusão; ≥4 mmol/L (ou 2× referência) = ressuscitação com 30 mL/kg; repetir em 2-4 h para clareamento (meta: queda ≥20% / tendência)	Coleta ≤1 h; resultado ≤30 min; enviar imediatamente ao laboratório (falso-positivo por demora)
2 hemoculturas de sítios distintos (+ 1 de cada lúmen de cateter se houver)	Colher antes do antimicrobiano se não atrasar >45 min; positividade cai a cada dose	≤1 h
Culturas dos sítios pertinentes	Urocultura (antes do ATB), escarro/aspirado, líquido, secreção de ferida, líquido pleural/ascítico	Antes do ATB quando factível
Gasometria arterial	pH, PaO ₂ /FiO ₂ <300, HCO ₃ ⁻ , acidose; SpO ₂ /FiO ₂ substituí P/F se sem gasometria (menos acurado no choque)	≤1 h
Hemograma, creatinina/ureia, bilirrubinas, coagulograma, eletrólitos, glicemia	Pesquisa das disfunções (plaquetas, creatinina, bilirrubina, INR); glicemia ≥180 → insulina	≤1 h
Urina I, RX tórax, ECG	Foco urinário/pulmonar; ECG para arritmia e isquemia tipo 2	≤1 h
POCUS	Derrame, consolidação, hidronefrose, líquido livre, abscesso, VCI/função cardíaca para guiar volume	Precoce se disponível
PCR / procalcitonina	Apoio, não decidem iniciar antibiótico (SSC 2026: clínica sozinha > procalcitonina para iniciar); PCT ajuda a suspender	—
Teste rápido dengue/malária/COVID/influenza	Conforme epidemiologia — muda o fluxo (Protocolo 11)	—

5. Fisiopatologia

A infecção dispara reconhecimento de padrões microbianos (PAMPs) e de dano (DAMPs) por receptores da imunidade inata, com liberação maciça de citocinas (TNF- α , IL-1, IL-6), ativação do complemento e do endotélio. O resultado é **vasodilatação** (óxido nítrico), **aumento de permeabilidade capilar** (glicocálix lesado → edema intersticial, hipovolemia relativa), **microtrombose** (ativação da coagulação, consumo de plaquetas → CIVD) e **disfunção mitocondrial** (hipóxia citopática mesmo com oferta de O₂ restaurada). O choque séptico é distributivo: débito cardíaco alto e resistência vascular baixa no início ("choque quente"), podendo evoluir com depressão miocárdica séptica ("choque frio"). O lactato sobe por hipoperfusão e por glicólise adrenérgica acelerada — por isso nem toda hiperlactatemia residual exige mais volume [ILAS 4.1.8]. A fase de imunoparalisia tardia explica infecções secundárias. Idosos, diabéticos e imunossuprimidos têm resposta atenuada (sem febre, sem leucocitose) e pior desfecho.

6. Fluxo de atendimento — primeiras 6 horas

O relógio começa na **hora da suspeita** (registrar no prontuário). Todas as ações do pacote correm em paralelo, não em sequência. Culturas não atrasam o antimicrobiano além de 45 min [ILAS 4.1.3].



6.1 Pacote da 1ª hora — checklist [ILAS 4.1; SSC 2026]

☐	Item	Meta de tempo
☐	Registrar hora da suspeita e abrir ficha do protocolo	0 min
☐	Lactato colhido e enviado	≤60 min (resultado ≤30 min)
☐	2 hemoculturas + culturas do foco antes do ATB	≤60 min (não atrasar ATB >45 min)
☐	Antimicrobiano IV de amplo espectro, dose plena, 1ª dose em bólus	≤60 min (choque ou sepse provável/definida); ≤3 h se sepse possível sem choque
☐	Cristaloide 30 mL/kg se hipotensão ou lactato ≥2× / hipoperfusão	Início ≤60 min; completar ≤3 h
☐	Noradrenalina se PAM <65 após volume (ou desde o início se choque instável)	≤60 min; via periférica aceitável
☐	Regulação para UTI acionada se choque ou disfunção grave	Imediata; admissão em UTI ≤6 h
☐	Reavaliação documentada da perfusão/volemia	A cada 30–60 min até 6 h

6.2 Metas hemodinâmicas e de perfusão

- **PAM ≥65 mmHg** (faixa ±5) — em **≥65 anos, 60–65 mmHg** é aceitável (SSC 2026, condicional); PA invasiva se vasopressor em dose intermediária/alta ou medidas não invasivas inconsistentes.
- **Diurese ≥0,5 mL/kg/h; TEC ≤3 s; lactato em queda** (não persegui-lo até normalizar); melhora do sensorio.
- Após os 30 mL/kg iniciais, volume adicional só com **evidência dinâmica de responsividade** (elevação passiva de MMII com resposta de PA/pulso, variação de pressão de pulso, POCUS de VCI) — estratégia liberal ou restritiva conforme o paciente e a disponibilidade de leito monitorado (SSC 2026).
- Após a fase aguda, **remoção ativa de fluidos** (diurético) se balanço muito positivo (SSC 2026).

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Fluidos

Item	Recomendação	Fonte
Tipo	Cristaloide (forte); preferir balanceado (Ringer lactato/Plasma-Lyte) a SF 0,9% (condicional, moderada); SF 0,9% se TCE associado. Sem amidos (forte contra); sem gelatina; albumina só após grandes volumes ou cirrose	SSC 2026
Volume inicial	≥30 mL/kg (peso real; ajustado/ideal se IMC >30) na presença de hipoperfusão/choque — iniciar na 1ª hora, completar em 3 h; alíquotas de 500 mL (250 mL em cardiopata/DRC) com reavaliação entre elas	ILAS 4.1.6; SSC 2026
Cardiopata / DRC / idoso	Mesmo racional, velocidade menor, reavaliação após cada alíquota (crepitações, SpO ₂ , POCUS); registrar no prontuário se optar por não completar os 30 mL/kg e considerar vasopressor mais precoce	ILAS 4.1.6

7.2 Vasopressores e inotrópicos [ILAS 4.1.7; SSC 2026]

Fármaco	Dose	Quando / observações
Noradrenalina (1ª escolha)	0,05–0,1 mcg/kg/min inicial, titular até 0,5 (doses maiores em refratário). Diluição prática: 4 ampolas (4 mg/4 mL cada = 16 mg) em 234 mL SG 5% → 64 mcg/mL [VERIFICAR apresentação local]	PAM <65 após volume, ou junto com volume se choque instável. Veia periférica calibrosa em fossa antecubital é aceitável até obter acesso central; vigiar extravasamento
Vasopressina	0,03 U/min fixa (não titular)	Adicionar quando noradrenalina em escalada (SSC 2026, moderada); poupa catecolamina. Disponibilidade [VERIFICAR]
Adrenalina	0,01–0,5 mcg/kg/min	3ª linha (ou 2ª se sem vasopressina); preferível se bradiarritmia; 1ª linha alternativa se disfunção cardíaca
Dobutamina	2,5–20 mcg/kg/min	Disfunção miocárdica com hipoperfusão persistente apesar de volume e PA adequadas — somada ao vasopressor, nunca no lugar dele
Dopamina	—	Não usar como 1ª linha (forte, alta certeza)
Hidrocortisona	50 mg IV 6/6 h (200 mg/dia)	Choque com necessidade de vasopressor em escalada/refratário (referência prática: noradrenalina ≥0,25 mcg/kg/min por ≥4 h — SSC 2021); SSC 2026 sugere corticoide IV no choque séptico. Suspender ao desmamar o vasopressor

7.3 Antimicrobiano empírico por foco — adulto, infecção comunitária [VERIFICAR com CCIH/REMUME]

Princípios [ILAS 4.1.4–5; SSC 2026]: dose plena e de ataque, **sem ajuste renal/hepático nas primeiras 24 h**; 1ª dose em bólus, manutenção de betalactâmicos em **infusão prolongada** (3–4 h) quando houver bomba (forte, moderada); cobrir MDR só com fator de risco (colonização/infecção prévia, ATB de amplo espectro prolongado, internação prolongada); **cobertura anaeróbia só se foco abdominal, ginecológico/obstétrico profundo, necrotizante de partes moles, cabeça e pescoço, abscesso de SNC/empiema**; sem antifúngico empírico de rotina; descalonar com cultura; duração curta com foco controlado.

Foco	Esquema sugerido (adulto, função renal normal nas 1as 24 h)	Alternativas / observações
Pulmonar (PAC grave)	Ceftriaxona 2 g IV 1×/dia (ou 1 g 12/12 h) + azitromicina 500 mg IV/VO 1×/dia (ou claritromicina 500 mg IV 12/12 h)	Alergia grave a betalactâmico: levofloxacino 750 mg IV 1×/dia. Aspiração com fator de risco anaeróbio: + clindamicina ou ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h. Influenza: oseltamivir 75 mg 12/12 h
Urinário (pielonefrite/uroseps)	Ceftriaxona 2 g IV 1×/dia	Sonda, ATB recente, ESBL prévio: piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h ou ertapenem 1 g 1×/dia; choque com risco MDR: meropenem 1 g 8/8 h. Obstrução → desobstruir (controle do foco)
Abdominal (peritonite, colangite, diverticulite, abscesso)	Ceftriaxona 2 g 1×/dia + metronidazol 500 mg IV 8/8 h; ou piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h	Grave/IRAS: meropenem 1 g 8/8 h. Avaliação cirúrgica precoce — transferir
Pele e partes moles	Celulite/erisipela grave: oxacilina 2 g IV 4/4 h ou cefazolina 2 g 8/8 h. Necrotizante: piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h + clindamicina 900 mg 8/8 h (+ vancomicina se MRSA) e cirurgia urgente	Pé diabético infectado grave: ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h ou pip-tazo. Suspeita de MRSA comunitário: + vancomicina ou clindamicina
Meningite bacteriana	Ceftriaxona 2 g IV 12/12 h + dexametasona 10 mg IV 6/6 h (antes/junto da 1ª dose); + ampicilina 2 g 4/4 h se >50 anos/imunossuprimido (Listeria)	Colher líquido se possível sem atrasar; notificar; isolamento respiratório 24 h

Foco	Esquema sugerido (adulto, função renal normal nas 1as 24 h)	Alternativas / observações
Foco indeterminado, comunitário	Ceftriaxona 2 g IV 1×/dia (+ metronidazol se abdome não excluído)	Choque + risco MDR/IRAS: piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h ou meropenem 1 g 8/8 h ± vancomicina (ataque 25–30 mg/kg, depois 15–20 mg/kg 12/12 h)
Neutropenia febril	Cefepima 2 g 8/8 h ou piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h	+ vancomicina se cateter/pele/instabilidade; transferir para referência oncológica
Cateter venoso central	Vancomicina + cobertura Gram-negativo (cefepima/pip-tazo); retirar o cateter	—

7.4 Suporte e medidas adjuvantes [ILAS 4.3; SSC 2026]

Medida	Conduta
Oxigênio / suporte ventilatório	Alvo SpO ₂ 90–96%; insuficiência respiratória hipoxêmica: cateter nasal de alto fluxo se disponível > VNI; prona acordada em não intubado tolerante; não postergar IOT se hipoperfusão + IRpA; ventilação protetora (VC 6 mL/kg peso ideal, platô <30, driving pressure <15)
Glicemia	Insulina se ≥180 mg/dL; evitar hipoglicemia
Transusão	Restritiva: Hb <7 g/dL (sem IAM/sangramento ativo)
Bicarbonato	Não usar para acidose láctica com pH >7,15–7,20; considerar se pH ≤7,2 com LRA estágio 2–3
Antitérmico	Só para conforto — não melhora desfecho
Profilaxia de TEV	Enoxaparina 40 mg SC 1×/dia (HBPM > HNF) salvo contraindicação
Profilaxia de úlcera de estresse	IBP se fator de risco de sangramento GI (coagulopatia, VM, hepatopatia)
Não recomendados	Vitamina C IV, imunoglobulina, vitamina D, hemoperfusão, terlipressina, betabloqueador para tratar o choque, procacitonina para decidir iniciar ATB
Controle do foco	Drenagem/desobstrução/desbridamento/retirada de cateter em ≤6 h — quase sempre requer transferência: acionar cedo
Hipertenso séptico	Vasodilatador IV de curta ação (nitroglicerina/nitroprussiato) se necessário; nunca anti-hipertensivo de ação prolongada

7.5 Notas pediátricas [SSC Pediatric 2020 — VERIFICAR contra a edição 2026 e o Protocolo de Pediatria]

- Reconhecer choque pela clínica: taquicardia para a idade, TEC >2 s ou flash, pulsos fracos ou amplos, alteração do sensorio, oligúria; hipotensão é tardia (PAS mínima = 70 + 2×idade).
- Antimicrobiano em ≤1 h no choque; em ≤3 h na sepse sem choque com suspeita persistente. Hemocultura antes se não atrasar.
- Fluidos: **com UTI disponível**, bólus de 10–20 mL/kg de cristalóide balanceado, reavaliando após cada um, até 40–60 mL/kg na 1ª hora ou até sinais de sobrecarga (hepatomegalia, estertores); **sem UTI e sem hipotensão**, não fazer bólus — apenas manutenção (SSC 2020). Como o PS não tem UTI, adotar bólus apenas com hipotensão ou hipoperfusão evidente e acionar transferência imediata.
- Vasoativo: adrenalina ou noradrenalina periférica/intraóssea se choque refratário a 40–60 mL/kg; hidrocortisona se refratário a vasoativo. Glicemia e cálcio: corrigir.
- Doses de antimicrobianos em mg/kg: **não citadas aqui de memória** — conferir bula/formulário pediátrico (dose lock institucional).

8. Como conduzir o caso — transferência, regulação e indicadores

8.1 Critérios de transferência

Situação	Urgência	Destino
Choque séptico (vasopressor) ou lactato ≥ 4 sem clareamento	Imediata (UTI em ≤ 6 h da suspeita)	UTI
≥ 2 disfunções orgânicas; necessidade de VNI/IOT; oligúria persistente/LRA com indicação de diálise	Imediata	UTI
Foco que exige controle cirúrgico/endoscópico/radiológico	≤ 6 h	Hospital com cirurgia/endoscopia
Sepse sem choque, estável após pacote, com 1 disfunção resolvendo	Mesmo dia se não houver leito de internação com monitorização por 24-48 h no PS	Enfermaria de referência
Meningite, neutropenia febril, gestante/puérpera séptica, criança em choque	Imediata	Referência específica

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 com monitor, oximetria, PA a cada 5 min, vasopressor em bomba de infusão (ou equipo microgotas com cálculo registrado), acesso duplo, O_2 /via aérea, material para IOT.
- Relatório com: hora da suspeita, foco presumido, disfunções presentes, **hora e dose do antimicrobiano**, culturas colhidas (quais, onde, hora), volume total infundido e horários, lactato inicial e de controle, dose atual de noradrenalina, diurese, exames, comorbidades, alergias, diretivas/limitação de suporte se houver.
- A ficha do protocolo acompanha o paciente [ILAS, seção 3.5]. Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência com UTI: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 Cuidados de fim de vida e metas de cuidado

Em paciente com definição prévia de cuidados paliativos exclusivos, o protocolo é descontinuado e o paciente recebe o tratamento proporcional (podendo incluir antimicrobiano e O_2 para conforto), sem entrar no denominador dos indicadores [ILAS 3.4]. O SSC 2026 recomenda discutir metas de cuidado e prognóstico com paciente/família precocemente (≤ 72 h).

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal) [ILAS]

Indicador	Meta
Tempo suspeita → antimicrobiano (mediana; % ≤ 1 h)	$\geq 80\% \leq 1$ h
% de lactato colhido em ≤ 1 h; % de hemoculturas antes do ATB	$\geq 90\%$
% de pacientes com hipotensão/lactato $\geq 2\times$ que receberam 30 mL/kg em ≤ 3 h	$\geq 80\%$
% de PAM < 65 com vasopressor iniciado em ≤ 1 h	100%
% de choque séptico admitido em UTI em ≤ 6 h	Registrar e melhorar
Conformidade total com o pacote da 1ª hora	$\geq 60\%$ (progressivo)
Letalidade por seps e por choque séptico (referência nacional ILAS 2024: 27,9% e ~52%)	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Definição de choque	ILAS/SSC: hipotensão refratária a volume com necessidade de vasopressor, independente do lactato; Sepsis-3 exige lactato >2. Adotada a operacional (ILAS) para abrir o pacote
Triagem	ILAS: SRIS + suspeita de infecção; SSC 2026: NEWS/MEWS/SIRS > qSOFA. Convergentes; qSOFA só para prognóstico
Tempo do antimicrobiano	ILAS: ≤1 h para todos em que o protocolo segue; SSC 2026: ≤1 h se choque ou sepse provável/definida, até 3 h se sepse possível sem choque. Adotada a graduação do SSC 2026 com meta institucional de 1 h
Volume dos 30 mL/kg	ILAS: dentro da 1ª hora; SSC 2026: iniciar imediatamente e completar em ≤3 h. Adotado: início na 1ª h, término ≤3 h, com reavaliação
Tipo de cristalóide	ILAS não especifica; SSC 2026 prefere balanceado. Adotado balanceado quando disponível [VERIFICAR estoque de Ringer lactato]
PAM em idoso	SSC 2026 (novo): 60–65 mmHg aceitável em ≥65 anos. Adotado com registro da decisão
Corticoide	ILAS: refratário; SSC 2021: noradrenalina ≥0,25 mcg/kg/min por ≥4 h; SSC 2026: sugere no choque séptico. Adotado: iniciar quando noradrenalina em escalada
Esquemas antimicrobianos	Sugestões de prática consagrada — obrigatória validação pela CCIH/SCIH e conferência de apresentações/diluições com a farmácia
Diluição de noradrenalina	Depende da ampola disponível (4 mg/4 mL vs 8 mg/4 mL) — padronizar tabela de infusão com a enfermagem [VERIFICAR]
Pediatria	SSC pediátrico 2026 publicado junto com o adulto — conteúdo não conferido nesta versão; manter SSC 2020 até revisão [VERIFICAR]

10. Referências

- Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS). *Implementação de protocolo gerenciado de sepse — protocolo clínico: atendimento ao paciente adulto com sepse/choque séptico*. Rev. ago/2018. ilas.org.br/wp-content/uploads/2022/02/protocolo-de-tratamento.pdf
- ILAS. *Nota técnica referente às atualizações das diretrizes da Surviving Sepsis Campaign de 2021*. ilas.org.br. ILAS. Relatório Nacional 2024.
- Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. *Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026*. Crit Care Med 2026 (doi 10.1097/CCM.0000000000007075); Intensive Care Med 2026 (doi 10.1007/s00134-026-08361-1).
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. *Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021*. Crit Care Med 2021;49(11):e1063-e1143.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. *The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*. JAMA 2016;315(8):801-810.
- Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, et al. *Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children*. Pediatr Crit Care Med 2020;21(2):e52-e106.
- Instituto Latino-Americano de Sepse / Conselho Federal de Medicina. *Sepse: um problema de saúde pública*. Brasília: CFM, 2016. 90 p.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de sepse (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração